Droit de la santé — Introduction

Droit — Licence 3 (L3)

Cours DRO-L3-23

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Découvrir le cadre juridique de la santé : sources du droit sanitaire, organisation du système de soins malien décrite par fonctions, droits des patients (information, consentement, dossier médical), secret médical, responsabilité médicale, encadrement des produits de santé et pouvoirs de police sanitaire — toujours en principes et en mécanismes, sans aucune donnée médicale.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Le droit de la santé : objet et sources
• Leçon 2 — L'organisation du système de santé au Mali : présentation
• Leçon 3 — Les droits des patients : information, consentement, dossier médical
• Leçon 4 — Le secret médical
• Leçon 5 — La responsabilité médicale : civile, pénale, administrative (aperçu)
• Leçon 6 — Les produits de santé et la pharmacie : encadrement (aperçu)
• Leçon 7 — Santé publique et pouvoirs de police sanitaire
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Le droit de la santé est le droit qui encadre tout ce qui touche à l'organisation des soins et à la protection de la santé des populations : qui peut soigner, où, avec quels produits, selon quelles règles, et avec quels droits pour la personne soignée. C'est un droit jeune et transversal : il emprunte au droit public pour l'organisation des services, au droit privé pour la relation entre le soignant et le patient, au droit pénal pour la protection des personnes, et au droit international pour les règles qui dépassent les frontières. Ce cours d'introduction en pose la carte, sans prétendre à l'exhaustivité.

Le Mali offre un terrain d'étude concret : un système de soins organisé en échelons, du centre de santé communautaire à l'hôpital national, un ministère chargé de piloter la politique sanitaire, des organismes qui gèrent les produits de santé et la couverture maladie, des mécanismes de solidarité encore en développement, et des questions vives — secret médical, consentement du patient, qualité et sécurité des produits de santé, mesures de police sanitaire. Le juriste y a pleinement sa place : dans les établissements de soins, les administrations, les organismes de couverture, les associations d'usagers, les organisations internationales et, bien sûr, au service des patients comme des professionnels, pour conseiller, rédiger, négocier ou plaider.

Avertissement de méthode, valable pour tout le cours : il s'agit d'un cours de droit, pas de médecine. Aucun fait médical, aucun protocole de soins, aucun conseil thérapeutique, aucune donnée sanitaire chiffrée ne sont enseignés ici ; les textes sont nommés en général et doivent être consultés dans leur version en vigueur, les organismes sont décrits par leurs fonctions plutôt que par des organigrammes figés, et

tous les dossiers étudiés sont fictifs, construits de toutes pièces pour apprendre à raisonner. À la fin de chaque corrigé, une mention te le rappellera : le raisonnement est pédagogique, la situation réelle exige les textes à jour et l'aide d'un professionnel du droit.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Situer l'objet du droit de la santé et classer ses sources : textes, déontologie, jurisprudence et droit international sanitaire.
- Décrire l'organisation du système de santé malien par fonctions : pilotage, échelons de soins, financement et mécanismes de couverture.
- Expliquer les droits des patients : information claire, consentement libre et éclairé, accès au dossier médical.
- Délimiter le secret médical : champ, titulaires, secret partagé encadré et exceptions présentées en catégories.
- Distinguer la faute de l'aléa et comparer les responsabilités civile, pénale et administrative en matière médicale.
- Présenter l'encadrement des produits de santé : autorisation de mise sur le marché, circuit pharmaceutique et pharmacovigilance, en mécanismes.
- Analyser les pouvoirs de police sanitaire à l'épreuve de la proportionnalité entre protection collective et libertés individuelles.

Leçon 1 — Le droit de la santé : objet et sources

L'objet du droit de la santé est plus large que le seul droit médical. Le droit médical, au sens étroit, gouverne la relation entre un soignant et un patient : droits du patient, devoirs du professionnel, responsabilité en cas de dommage. Le droit de la santé, lui, englobe en outre l'organisation du système de soins (établissements publics et privés, professions réglementées), le financement et la couverture du risque maladie, l'encadrement des produits de santé, ainsi que la santé publique, c'est-à-dire la protection de la santé des populations entières. Le juriste de la santé travaille donc à la croisée du droit administratif, du droit civil, du droit pénal, du droit du travail et du droit international.

Ses sources forment une architecture en couches. Au sommet, la Constitution affirme en principe la protection de la santé comme une exigence adressée aux pouvoirs publics. Viennent ensuite les lois et règlements sanitaires, nommés ici en général : organisation des professions de santé, règles applicables aux établissements, droits des usagers, police sanitaire. S'y ajoutent les codes de déontologie propres à chaque profession de santé, qui fixent les devoirs entre confrères et envers les patients, la jurisprudence des juridictions nationales, et le droit international sanitaire, porté notamment par l'Organisation mondiale de la Santé et ses instruments de coopération, comme le règlement sanitaire international, nommé lui aussi en général.

Trois tensions structurent la matière et reviendront dans tout le cours. Première tension : protéger la santé collective peut limiter des libertés individuelles — c'est le problème de la police sanitaire, traité en leçon 7. Deuxième tension : la sécurité des

soins et des produits doit être garantie sans rendre l'accès aux soins impossible — c'est le problème de l'encadrement pharmaceutique, traité en leçon 6. Troisième tension : le soignant détient un savoir et un pouvoir sur la personne soignée, que les droits du patient et le secret médical viennent équilibrer — ce sont les leçons 3 et 4. Savoir repérer quelle tension est en jeu, et quelles sources la gouvernent, est le premier réflexe du juriste de la santé.

L'essentiel
Le droit de la santé dépasse le droit médical : il organise le système de soins, encadre les professions et les produits, protège les patients et la santé publique. Ses sources combinent Constitution, lois et règlements sanitaires, déontologies professionnelles, jurisprudence et droit international sanitaire.

Exemple — Cartographie des sources — trois situations fictives

```
DOSSIER D'ÉCOLE — situations fictives, à classer par sources

Situation A (fictive) : une usagère se voit refuser la
communication de son dossier de soins par un établissement.
-> Question : droits des patients (information, accès au
dossier) — sources : lois sanitaires générales sur les
droits des usagers + déontologie + vie privée.

Situation B (fictive) : une commune veut faire fermer un
point de vente d'eau dont l'insalubrité est constatée.
-> Question : police sanitaire et salubrité publique —
sources : droit administratif, pouvoirs de police,
textes sanitaires nommés en général.

Situation C (fictive) : une officine met en rayon un produit
de santé dépourvu d'autorisation.
-> Question : encadrement des produits de santé —
sources : mécanisme d'autorisation, circuit pharmaceutique,
responsabilités en catégories.

Lecture : un même mot, « santé », trois tensions différentes
(patient, collectivité, produit) et trois faisceaux de sources.
```

À retenir

- Droit médical (la relation de soins) et droit de la santé (tout le système) ne se confondent pas : le second contient le premier.
- Les sources sont plurielles : textes sanitaires, déontologies, jurisprudence, droit international — toujours à consulter en vigueur.
- Repérer la tension en jeu (patient, collectivité, produit) est le premier pas de toute analyse en droit de la santé.

Exercice

Pour chacune de ces situations fictives, indique la tension principale en jeu et le faisceau de sources à mobiliser : 1) un patient fictif reproche à un établissement de ne pas l'avoir informé avant un acte de soins programmé ; 2) une autorité fictive ordonne

la fermeture temporaire d'un marché pour insalubrité ; 3) un grossiste fictif distribue un produit de santé retiré du circuit par décision de l'autorité compétente.

✔ Corrigé
1) Tension « patient » : c'est la relation de soins qui est en cause — information et consentement (leçon 3) ; sources : lois sanitaires générales sur les droits des usagers, code de déontologie de la profession concernée, principes de la responsabilité (leçon 5). 2) Tension « collectivité » : la protection de la santé publique justifie une mesure contraignante, à contrôler sous l'angle de la proportionnalité (leçon 7) ; sources : droit administratif, textes de police sanitaire nommés en général, jurisprudence sur les libertés. 3) Tension « produit » : la sécurité des produits prime sur la liberté du commerce (leçon 6) ; sources : mécanisme d'autorisation et de retrait, règles du circuit pharmaceutique, responsabilités en catégories. Dans les trois cas, on ne cite aucun texte de mémoire : on identifie la question, puis on va aux sources en vigueur. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les textes sanitaires en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 2 — L'organisation du système de santé au Mali : présentation

Le système de santé malien se décrit d'abord par ses fonctions de pilotage. Le ministère chargé de la santé définit la politique sanitaire, édicte les normes, planifie l'offre de soins et contrôle les acteurs ; il s'appuie sur des directions et des programmes verticaux décrits par leurs missions, et sur des organismes placés sous sa tutelle — par exemple, en fonction, l'autorité chargée des produits de santé ou l'organisme gestionnaire de l'assurance maladie. Les collectivités territoriales exercent, elles aussi, des compétences de proximité en matière d'équipements et de salubrité. Pour le juriste, l'essentiel est de savoir qui décide quoi : une norme de soins ne vient pas du même niveau qu'une décision d'ouverture d'établissement ou qu'une mesure de police locale.

L'offre de soins s'organise en pyramide d'échelons, reliés par un mécanisme de référence : on entre en principe par l'échelon le plus proche, qui oriente vers l'échelon supérieur quand le plateau technique nécessaire dépasse ses moyens, avec un retour d'information en sens inverse. À la base, les centres de santé communautaires, gérés avec la participation des communautés à travers leurs associations de santé, assurent les soins de proximité. Au-dessus, le centre de santé de référence du district coordonne et reçoit les cas référés ; puis l'hôpital régional, et au sommet les hôpitaux nationaux et centres spécialisés, qui concentrent les plateaux techniques les plus lourds et les fonctions de formation et de recherche. Le secteur privé — cliniques, cabinets, officines — et les acteurs confessionnels ou associatifs complètent l'offre, sous le contrôle de l'État.

Le financement combine plusieurs sources : le budget de l'État, l'aide des partenaires, la contribution directe des usagers au point de service, et des mécanismes de couverture destinés à mutualiser le risque maladie. L'assurance maladie repose sur une logique de solidarité : des cotisations ou des financements publics alimentent un fonds qui paie tout ou partie des soins des bénéficiaires, selon des règles de prise en

charge définies par les textes en vigueur ; à côté, des mécanismes d'assistance médicale visent les personnes démunies, et des mutuelles de santé communautaires organisent une solidarité de proximité. Le juriste retiendra le principe, sans retenir de taux : les paramètres financiers relèvent de textes et de décisions qui évoluent, et l'enjeu juridique constant est l'égalité d'accès aux soins malgré l'inégalité des ressources.

L'essentiel
Pilotage par le ministère et ses organismes, offre de soins en pyramide (centre de santé communautaire, centre de référence de district, hôpital régional, hôpitaux nationaux) reliée par la référence, pluralité des acteurs publics et privés, et financement mixte où les mécanismes de couverture mutualisent le risque maladie.

Exemple — Organigramme fonctionnel d'un district sanitaire fictif

```
DISTRICT SANITAIRE FICTIF DE « ZAMBOUGOU-SUR-FLEUVE »
(organigramme d'école — aucun établissement réel)

PILOTAGE
Équipe cadre du district : planifie, supervise, coordonne
les formations sanitaires de son aire de responsabilité.
ÉCHELONS DE SOINS (de la base vers le sommet)
Centres de santé communautaires (aires de santé) :
soins de proximité, gestion participative communautaire.
Centre de santé de référence du district :
reçoit les références, plateau technique intermédiaire.
Hors district : hôpital régional, puis hôpitaux nationaux
(référence de dernier niveau, formation, recherche).
FONCTIONS TRANSVERSES
Pharmacie du district : approvisionnement en produits.
Hygiène et salubrité : inspections, appui aux communes.
Couverture : point focal des mécanismes d'assurance et
d'assistance pour les bénéficiaires du district.
BUDGET ANNUEL FICTIF DU DISTRICT (données d'exercice)
Fonctionnement des services .... 18 000 000 F
Supervision et coordination ..... 12 000 000 F
Appui aux centres de santé ...... 45 000 000 F
TOTAL ........................... 75 000 000 F
(45 000 000 + 18 000 000 + 12 000 000 = 75 000 000)
```

À retenir

- Décrire le système par fonctions (piloter, soigner, financer, contrôler) évite de figer un organigramme que les réformes font évoluer.
- La pyramide des soins fonctionne par référence : chaque échelon soigne ce qu'il peut et oriente le reste vers l'échelon adapté.
- La couverture maladie est un mécanisme de mutualisation du risque ; ses paramètres chiffrés relèvent des textes en vigueur, pas de ce cours.

Exercice

Dans le district fictif de l'exemple, trois demandes arrivent le même jour : 1) le responsable d'un centre de santé communautaire demande qui valide le plan d'action annuel de son aire ; 2) une usagère veut savoir pourquoi son centre l'oriente vers le centre de référence au lieu de la soigner sur place ; 3) un bénéficiaire d'un mécanisme de couverture conteste un reste à payer. Pour chaque demande, indique la fonction concernée et l'interlocuteur approprié, en restant au niveau des principes.

✔ Corrigé
1) Fonction de pilotage : le plan d'action s'inscrit dans la planification du district ; l'interlocuteur est l'équipe cadre du district, qui coordonne et supervise les formations sanitaires de son aire. 2) Fonction d'organisation des soins : la référence n'est pas un refus de soins mais le fonctionnement normal de la pyramide — chaque échelon traite ce que son plateau technique permet et oriente le reste, avec un retour d'information ; l'explication doit être donnée à l'usagère, car l'orientation relève aussi de son droit à l'information (leçon 3). 3) Fonction de couverture : le reste à payer dépend des règles de prise en charge du mécanisme (part couverte, part restant à la charge du bénéficiaire) ; l'interlocuteur est le point focal couverture du district, puis l'organisme gestionnaire, et le litige relève des voies de recours prévues par les textes en vigueur. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les textes sanitaires en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 3 — Les droits des patients : information, consentement, dossier médical

Le premier droit du patient est le droit à l'information. Le professionnel de santé doit à la personne soignée une information claire, loyale et adaptée à sa compréhension : sur son état, sur les investigations et les soins proposés, sur leurs bénéfices attendus et leurs risques sérieux, et sur les alternatives raisonnables, y compris celle de ne rien faire. Cette information n'est pas une formalité : elle est la condition d'une décision libre. Elle est en principe délivrée oralement, dans un dialogue, et sa délivrance doit pouvoir être établie en cas de contestation — d'où l'importance des traces dans le dossier. Le patient peut aussi, symétriquement, exprimer la volonté de ne pas être informé, volonté que le soignant respecte tout en en gardant la trace, hors les cas où des tiers seraient exposés à un risque.

Le deuxième droit est le consentement : aucun acte de soins ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, qui peut le retirer à tout moment. Libre, c'est-à-dire sans pression ; éclairé, c'est-à-dire précédé de l'information décrite ci-dessus : le consentement est donc un processus, pas une signature. Le refus de soins est le revers du même droit : il doit être entendu, expliqué dans ses conséquences, tracé au dossier — et il ne fait pas disparaître le devoir d'accompagnement du soignant. Certaines situations aménagent le mécanisme sans le supprimer : l'urgence, où l'impossibilité de recueillir la volonté fait primer le devoir d'assistance ; les personnes protégées, pour lesquelles un représentant intervient selon des catégories fixées par les textes ; et la possibilité de désigner une personne de confiance, qui sera consultée si le patient ne peut plus s'exprimer.

Le troisième droit étudié ici est l'accès au dossier médical. Le dossier rassemble, en catégories, les informations formalisées recueillies au cours de la prise en charge : comptes rendus, résultats d'examens, correspondances entre professionnels, traces des informations données et des consentements recueillis. Il sert d'abord la continuité des soins ; il sert aussi de mémoire juridique des deux côtés. Le patient — ou, selon les cas prévus par les textes, son représentant ou ses ayants droit — peut y accéder, directement ou par l'intermédiaire d'un professionnel qu'il désigne, dans des conditions de forme et de coût encadrées : seuls des frais de reproduction peuvent en principe être mis à sa charge. L'établissement, lui, a le devoir de conserver le dossier de manière sûre et confidentielle, ce qui relie ce droit au secret médical de la leçon suivante et, pour les données numériques, à la protection des données personnelles étudiée au cours DRO-L3-18.

L'essentiel
Information claire et adaptée, consentement libre et éclairé conçu comme un processus (avec son revers, le refus), accès au dossier médical : trois droits qui font du patient un décideur de sa propre prise en charge, et du dossier la mémoire juridique de la relation de soins.

Exemple — Dossier de consentement fictif complet — un soin générique non décrit

```
DOSSIER D'ÉCOLE — établissement et patient fictifs
« Centre de soins fictif du district de Zambougou »
Soin concerné : « acte de soins programmé » (nature non
précisée volontairement : seul le mécanisme est étudié).

ÉTAPES DU PROCESSUS (mécanisme, pas un protocole médical)
1. Accueil et vérification de l'identité de la personne.
2. Entretien d'information : état, acte envisagé, bénéfices
attendus, risques sérieux, alternatives — en langage
clair, avec interprète si besoin.
3. Questions de la personne ; réponses notées au dossier.
4. Temps de réflexion laissé à la personne (aucune durée
n'est fixée ici : c'est un principe d'exercice).
5. Décision : accord ou refus, exprimé librement ;
en cas d'accord, trace écrite d'école signée.
6. Versement au dossier médical : information délivrée,
décision, identité de la personne de confiance
éventuellement désignée.
7. Rappel du droit d'accès au dossier : demande auprès de
l'établissement, accès direct ou par un professionnel
désigné ; seuls des frais de reproduction sont en
principe facturables (exercice : 40 pages x 50 F
= 2 000 F de frais de copie, données fictives).
```

À retenir

- Le consentement valable suppose deux conditions cumulatives : une information préalable compréhensible et une volonté libre, révocable.

• Le refus de soins est un droit : il s'entend, s'explique, se trace — il ne met pas fin au devoir d'accompagnement.

• Le dossier médical appartient juridiquement à la relation de soins : le patient y accède, l'établissement le conserve sous le sceau de la confidentialité.

Exercice

Cas fictif : avant un acte de soins programmé, un patient fictif signe en quelques secondes un formulaire qu'on lui tend, sans aucun entretien ; il conteste ensuite avoir été informé. À l'inverse, une patiente fictive refuse un acte après un long entretien, et sa décision est versée au dossier. Analyse les deux situations au regard des conditions du consentement.

✔ Corrigé

Première situation : la signature ne suffit pas. Le consentement doit être éclairé, donc précédé d'une information adaptée et d'un véritable dialogue ; un formulaire signé sans entretien laisse le consentement fragile, et en cas de contestation, c'est à celui qui se prévaut du consentement d'établir que l'information a bien été délivrée — le dossier ne contenant aucune trace d'entretien, la preuve fera défaut. Deuxième situation : le refus est l'exercice normal du droit de consentir ; recueilli après information complète et tracé au dossier, il est juridiquement solide, et le soignant conserve son devoir d'accompagnement et de proposition d'alternatives. La leçon commune : le droit retient le processus (informer, dialoguer, tracer), pas la seule signature. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les textes sanitaires en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 4 — Le secret médical

Le secret médical est l'interdiction faite à tout professionnel de santé de révéler ce qu'il a appris, vu, entendu ou compris à l'occasion de l'exercice de sa profession. Il couvre donc bien plus que le contenu du dossier : un nom sur une liste de rendez-vous, une confidence faite en marge du soin, une simple présence dans un service peuvent être secrets. Son fondement est double : protéger la vie privée de la personne, et rendre possible la confiance sans laquelle les patients tairaient des informations nécessaires à leur prise en charge. Il prolonge, dans le champ sanitaire, le secret professionnel étudié au cours DRO-L2-14, et il est sanctionné en catégories civiles, disciplinaires et pénales lorsque sa violation est établie.

Le secret n'interdit pas tout partage : il l'encadre. D'abord, le patient lui-même peut délier le professionnel du secret qui le concerne, par un consentement exprès et éclairé — c'est son secret, il en dispose. Ensuite, à l'intérieur d'une équipe de soins, le secret est dit « partagé » : les professionnels qui participent à la prise en charge d'une même personne peuvent s'échanger les informations strictement nécessaires à la continuité et à la qualité des soins, sauf opposition de la personne informée de ce partage. Enfin, les transmissions entre professionnels — par exemple lors d'une référence vers un autre échelon de la pyramide des soins (leçon 2) — doivent rester limitées au nécessaire et emprunter des canaux sûrs. La règle de gestion est simple à énoncer, exigeante à tenir : ne transmettre que ce qui est nécessaire, à qui en a

besoin, avec la trace de la transmission.

Des exceptions, présentées ici uniquement en catégories, autorisent ou imposent parfois de parler. Certaines obligations légales de déclaration, nommées en général, priment sur le secret : déclarations administratives prévues par les textes, par exemple en matière d'état civil ou de surveillance sanitaire. L'autorité judiciaire peut, dans les formes prévues, procéder à des réquisitions ou à des saisies encadrées. La protection d'une personne en danger — notamment un mineur ou une personne vulnérable — est discutée comme une hypothèse où la loi peut ouvrir une faculté de signalement, à manier avec une prudence extrême. Et l'urgence impose parfois de transmettre à l'équipe qui prend le relais ce qui est indispensable. Le juriste retiendra la méthode : pas d'exception sans base légale identifiable, pas de révélation au-delà de ce que l'exception autorise, et une trace écrite de la décision et de ses motifs.

L'essentiel
Le secret médical couvre tout ce que le professionnel apprend dans l'exercice ; il appartient au patient, qui peut en délier le soignant. Le secret partagé au sein de l'équipe de soins et des exceptions légales en catégories l'aménagent sans le supprimer.

Exemple — Demandes de tiers fictifs — traitement par les mécanismes

```
DOSSIER D'ÉCOLE — trois demandes reçues par un centre fictif

Demande 1 : un employeur fictif réclame « le motif médical »
de l'absence d'un salarié fictif, certificat à l'appui.
-> RÉPONSE : refus motivé. Le certificat justifie l'absence,
il ne révèle pas la cause ; l'employeur n'est pas
destinataire du secret. Trace de la demande au dossier.

Demande 2 : un assureur fictif demande le dossier complet
« pour instruire le remboursement ».
-> RÉPONSE : pas de transmission sans l'accord exprès de
la personne concernée ; si accord, transmission limitée
aux pièces nécessaires, par canal sûr, avec trace.

Demande 3 : l'équipe de l'échelon supérieur demande les
informations utiles à la prise en charge d'un patient
référé depuis le centre.
-> RÉPONSE : secret partagé — transmission des informations
strictement nécessaires à la continuité des soins,
personne informée du partage, trace au dossier.

Fil conducteur : identifier le demandeur, sa qualité,
la base légale éventuelle, puis décider — et tracer.
```

À retenir

- Le secret couvre ce qui est appris, vu, entendu ou compris dans l'exercice — y compris la simple présence d'une personne dans un service.

• Trois canaux légitimes seulement : la volonté du patient, le secret partagé entre soignants pour la continuité, l'exception prévue par un texte.

• Toute décision de transmettre ou de refuser se motive, se limite au nécessaire et se trace au dossier.

Exercice

Classe ces demandes fictives en trois groupes (transmission possible après accord du patient ; secret partagé entre soignants ; refus motivé) et justifie chaque classement : 1) un confrère fictif du même établissement demande les résultats utiles à la suite de la prise en charge ; 2) un journaliste fictif demande si une personnalité est hospitalisée dans le service ; 3) une patiente fictive demande que ses résultats soient transmis au médecin fictif de son choix, dans une autre ville ; 4) un voisin fictif « vient aux nouvelles » d'un patient.

✔ Corrigé

1) Secret partagé : même prise en charge, transmission limitée aux informations nécessaires à la continuité, patiente informée, trace au dossier. 2) Refus motivé : la simple présence d'une personne dans un service est couverte par le secret ; aucune base légale ne permet de répondre, et confirmer comme infirmer serait déjà révéler. 3) Transmission possible après accord : la patiente dispose de son secret ; son accord exprès et éclairé délie le professionnel, la transmission vise le destinataire qu'elle désigne et se limite au nécessaire. 4) Refus motivé : le voisin n'a aucune qualité pour recevoir des informations couvertes ; la politesse commande une réponse courtoise mais ferme, sans aucune confirmation indirecte. La méthode est constante : qualité du demandeur, base légale, accord éventuel, nécessité, trace. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les textes sanitaires en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 5 — La responsabilité médicale : civile, pénale, administrative (aperçu)

Toute prise en charge comporte une part d'incertitude : un dommage peut survenir alors même qu'aucune faute n'a été commise. Le droit distingue donc la faute — un manquement aux devoirs de prudence, de diligence ou d'information qui s'imposent au professionnel — de l'aléa, événement dommageable qui se réalise sans qu'un manquement puisse être reproché. Cette distinction commande tout le régime : la responsabilité pour faute suppose le triptyque classique déjà rencontré dans le droit de la responsabilité (cours DRO-L2-02) — une faute, un dommage, un lien de causalité entre les deux. Le soignant est en principe tenu d'une obligation de moyens : il doit mettre en œuvre des soins consciencieux et conformes aux données acquises de la science, sans promettre un résultat de guérison. À côté de la faute technique, la faute d'information — défaut d'information sur les risques sérieux d'un acte — engage la responsabilité sur le terrain du consentement (leçon 3).

Trois ordres de responsabilité peuvent être mobilisés, avec des fonctions différentes. La responsabilité civile vise à réparer : elle oppose le patient au professionnel libéral ou à l'établissement privé, devant le juge civil. La responsabilité administrative

concerne le service public de soins : devant le juge administratif, on distingue en idées la faute de service, qui engage l'établissement public, de la faute personnelle détachable, qui peut engager l'agent ; c'est le régime qui gouverne les hôpitaux publics. La responsabilité pénale, elle, sanctionne : elle suppose une infraction — par exemple, en catégories, une atteinte involontaire à la personne ou la violation du secret — prouvée selon les exigences du procès pénal, qui ne se confond jamais avec la seule survenance d'un dommage. S'y ajoute la responsabilité disciplinaire devant l'ordre professionnel, qui protège la déontologie de la profession. Ces ordres sont indépendants : un même fait peut nourrir plusieurs procédures aux fins différentes.

La preuve est le nerf du contentieux médical. Le dossier médical (leçon 3) en est la pièce maîtresse : complet et tracé, il protège le patient comme le soignant ; lacunaire, il nourrit les présomptions contre celui qui devait le tenir. Parce que les questions sont techniques, le juge recourt à l'expertise : un expert éclaire le tribunal sur les pratiques attendues et sur le lien de causalité, dans une procédure contradictoire où chaque partie peut discuter ses conclusions — mais c'est le juge, jamais l'expert, qui tranche la question de droit. Des voies amiables existent en amont : réclamation auprès de l'établissement, médiation, transaction ; et l'assurance de responsabilité professionnelle joue un rôle central dans l'indemnisation effective. L'indemnisation, quand elle est due, répare les préjudices établis poste par poste, sans barème automatique : chaque montant discuté doit être justifié.

L'essentiel
Pas de responsabilité sans faute prouvée, dommage et lien de causalité — l'aléa sans faute ne suffit pas ; le soignant doit des moyens consciencieux, pas un résultat. Civile, administrative et pénale répondent à trois fonctions : réparer dans le privé, réparer dans le service public, sanctionner l'infraction.

Exemple — Différend fictif d'indemnisation — expertise et partage raisonnés

```
DOSSIER D'ÉCOLE — faits médicaux volontairement NON décrits
Seul le raisonnement juridique et chiffré est étudié.

DEMANDE DE LA PERSONNE (montants fictifs, en francs)
Frais restés à sa charge ......... 900 000
Perte de revenus alléguée ........ 2 000 000
Préjudice moral allégué .......... 1 600 000
TOTAL DEMANDÉ ..................... 4 500 000
(900 000 + 2 000 000 + 1 600 000 = 4 500 000)

EXPERTISE (mécanisme)
Expert désigné ; opérations contradictoires ; le rapport
retient un manquement partiellement à l'origine du
dommage et évalue la part imputable à 60 % (donnée
d'exercice, non un barème).

PARTAGE RAISONNÉ
Préjudices établis ................ 4 500 000
Part imputable (60 %) ............. 2 700 000
(4 500 000 x 60 / 100 = 2 700 000)
Solde non imputable (aléa) ....... 1 800 000
Le juge reste libre d'apprécier le rapport d'expertise.
```

À retenir

- Faute, dommage, causalité : sans l'un des trois, pas de responsabilité pour faute — le dommage seul ne suffit jamais.
- L'obligation du soignant est en principe une obligation de moyens ; la faute d'information est une voie autonome d'engagement.
- L'expertise éclaire, le juge décide ; le dossier médical complet est la meilleure protection des deux parties.

Exercice

Qualifie juridiquement ces trois situations fictives et abstraites (faute envisageable / aléa sans faute / question d'information) et dis ce qu'il faudrait établir pour engager une responsabilité : 1) un dommage survient alors que le dossier fictif montre des soins conformes aux données acquises et une traçabilité complète ; 2) un acte est réalisé sans qu'aucune information sur ses risques sérieux figure au dossier fictif, et un tel risque se réalise ; 3) un résultat décevant est invoqué, mais le demandeur ne produit ni dossier ni élément sur le déroulement des soins fictifs.

✔ Corrigé
1) Aléa sans faute : soins conformes et tracés, aucun manquement identifiable ; la responsabilité pour faute ne peut pas être engagée, le triptyque étant incomplet — la discussion se déplace éventuellement vers les mécanismes de solidarité prévus par les textes, sans confusion avec une faute. 2) Question d'information : la voie est celle du consentement (leçon 3) ; il faudra établir qu'un risque sérieux n'a pas été porté à la connaissance du patient et que, informé, il aurait pu décider autrement — le préjudice réparable se rattache alors à cette perte de chance de décider. 3) Demande fragile : sans éléments sur le déroulement des soins, ni faute ni causalité ne sont établies ; le dossier médical, à demander selon les mécanismes d'accès, et le cas échéant une expertise, sont les étapes préalables à toute qualification. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les textes sanitaires en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 6 — Les produits de santé et la pharmacie : encadrement (aperçu)

Un produit de santé n'est pas un bien de consommation ordinaire : il agit sur le corps, et son défaut peut nuire gravement. Le droit l'encadre donc de sa fabrication à sa dispensation. La notion se présente en catégories : les médicaments, les dispositifs médicaux (le matériel et les instruments), les produits issus du corps humain en catégories abstraites, et les produits frontières que les textes classent selon leur destination. Au centre du dispositif, une idée simple : aucun produit ne doit circuler librement sans une évaluation préalable de sa qualité, de sa sécurité et de son utilité, conduite par une autorité compétente décrite ici par sa fonction — l'administration chargée de la pharmacie et du médicament, qui instruit, autorise, inspecte et peut retirer.

Le mécanisme central est l'autorisation de mise sur le marché : le fabricant ou l'importateur constitue un dossier démontrant la qualité du produit, sa sécurité d'emploi et son intérêt ; l'autorité l'évalue et autorise, refuse ou assortit la mise sur le marché de conditions. Le produit autorisé entre ensuite dans un circuit organisé : fabrication et importation contrôlées, distribution en gros par des établissements autorisés, dispensation au public par les officines de pharmacie. Le monopole pharmaceutique — la réservation de la dispensation aux pharmaciens — se justifie par la compétence et la responsabilité du dispensateur, qui vérifie notamment les ordonnances lorsque le produit en exige une. Le revers de ce circuit officiel est le marché informel des produits de santé, vendus hors de tout contrôle : le droit le combat par des catégories d'infractions et par l'inspection, car un produit falsifié ou mal conservé expose la population à un risque que le prix bas ne compense jamais.

L'encadrement ne s'arrête pas à la mise sur le marché : il se poursuit par la pharmacovigilance. Les professionnels et les établissements signalent les effets indésirables et les incidents dont ils ont connaissance ; l'autorité centralise ces signaux, les évalue, et peut décider des mesures graduées : information des professionnels, restriction d'emploi, suspension ou retrait d'un lot, voire de l'autorisation. Les établissements, de leur côté, organisent la traçabilité : savoir quel

lot a été reçu, stocké et dispensé permet un retrait effectif. Enfin, si un produit défectueux cause un dommage, la responsabilité du fait des produits peut être recherchée selon les mécanismes généraux du droit de la responsabilité, en plus des suites administratives et pénales en catégories. Le juriste retiendra la logique d'ensemble : autoriser avant, surveiller pendant, retirer et réparer après.

L'essentiel
Les produits de santé circulent sous contrôle : autorisation préalable fondée sur un dossier d'évaluation, circuit organisé sous monopole pharmaceutique de dispensation, pharmacovigilance et retraits gradués après la mise sur le marché.

Exemple — Produit fictif « Sirop Zambé » — autorisation et vigilance en fonctions

```
DOSSIER D'ÉCOLE — produit, fabricant et chiffres fictifs

PARCOURS D'AUTORISATION (mécanisme, étapes fonctionnelles)
1. Dépôt du dossier par le fabricant fictif : qualité,
sécurité, intérêt du produit « Sirop Zambé ».
2. Instruction par l'autorité compétente (fonction) :
évaluation documentaire, questions complémentaires.
3. Décision : autorisation assortie de conditions
(présentation, mentions obligatoires, circuit visé).
4. Entrée dans le circuit : grossiste autorisé, puis
officines ; traçabilité par numéro de lot.

VIGILANCE (mécanisme)
Signalements d'effets indésirables reçus : 3 (fictifs),
rattachés au même lot fictif n° Z-104.
Mesure graduée décidée : retrait du lot.
Stock du lot chez le grossiste fictif : 2 400 flacons
Déjà écoulés vers les officines : 1 800 flacons
Retirés des rayonnages .......... : 600 flacons
(1 800 + 600 = 2 400 : le stock est intégralement tracé)
Information des officines et du public par l'autorité.
```

À retenir

- L'autorisation de mise sur le marché est un mécanisme d'évaluation préalable : qualité, sécurité, intérêt — pas un simple enregistrement.
- Le monopole de dispensation protège le public : hors du circuit officiel, ni qualité ni conservation ni recours ne sont garantis.
- La pharmacovigilance boucle le système : signaler, évaluer, graduer la mesure — jusqu'au retrait du lot ou de l'autorisation.

Exercice

Un produit fictif, le « Baume Zambara », est proposé à la vente sur un étal de marché par un vendeur fictif sans qualité, à un prix très inférieur à celui des officines. Un acheteur fictif demande au juriste : « c'est le même produit, pourquoi l'acheter plus cher en officine ? » Construis la réponse juridique en trois temps : le circuit, le risque, les recours.

✔ Corrigé
Le circuit : le produit de santé ne peut être dispensé que dans le circuit organisé — grossistes autorisés et officines placées sous la responsabilité d'un pharmacien ; la vente sur un étal échappe à toute autorisation de dispensation et expose le vendeur aux suites prévues en catégories. Le risque : hors circuit, rien ne garantit ni l'authenticité du produit (produit falsifié possible), ni ses conditions de conservation, ni sa traçabilité par lot — en cas d'incident, aucun retrait ciblé n'est possible. Les recours : en officine, l'acheteur dispose d'un vendeur identifiable et responsable, d'une traçabilité permettant le signalement en pharmacovigilance, et des voies de responsabilité en cas de produit défectueux ; sur le marché informel, ces trois protections disparaissent. La différence de prix rémunère donc une chaîne de garanties juridiques, pas seulement le produit. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les textes sanitaires en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 7 — Santé publique et pouvoirs de police sanitaire

La police sanitaire est l'ensemble des mesures que les autorités peuvent prendre pour protéger la santé des populations : elle ne soigne pas des individus, elle prévient des risques collectifs. En temps ordinaire, elle s'exerce par des règlements et des contrôles : salubrité des lieux recevant du public, qualité sanitaire des eaux et des denrées mises en vente, hygiène des établissements, gestion des déchets, inspections par des services compétents décrits par leurs fonctions. Ces pouvoirs appartiennent, selon les matières, à l'État — ministère chargé de la santé, représentants territoriaux de l'État — et aux collectivités, dont les édiles exercent une police de proximité. Comme toute police administrative, elle est préventive, elle peut contraindre avant tout dommage, et elle s'exerce sous le contrôle du juge administratif (cours DRO-L2-12), gardien de la légalité des mesures.

En situation d'urgence sanitaire, les pouvoirs se renforcent : l'autorité peut être amenée à restreindre des activités, à imposer des mesures d'isolement sanitaire en catégories, à réglementer des rassemblements ou des déplacements, à réquisitionner des moyens. Le droit n'abandonne pas pour autant ses exigences, que le cours DRO-L1-24 sur l'état d'urgence et les libertés a déjà posées : une base légale pour les mesures, une nécessité démontrée par la situation, une proportionnalité entre la mesure et le risque, un caractère temporaire et réexaminé, et un contrôle juridictionnel effectif. La proportionnalité se décompose en trois questions que tout juriste doit savoir poser : la mesure est-elle apte à atteindre le but sanitaire ? Est-elle nécessaire, faute d'une mesure moins contraignante également efficace ? Le sacrifice imposé aux libertés est-il supportable au regard du bénéfice collectif attendu ?

Le débat de fond oppose deux lectures qu'il faut exposer loyalement. D'un côté, la protection de la santé est une condition de toutes les autres libertés : sans elle, ni école, ni travail, ni vie sociale ; des mesures rapides et générales seraient donc le prix d'une protection égale pour tous, et leur contestation permanente paralyserait l'action publique. De l'autre, les restrictions touchent des libertés essentielles — aller et venir,

travailler, se réunir — et frappent plus durement les plus démunis ; des mesures générales et prolongées, faiblement contrôlées, feraient glisser l'exception vers la norme. Le droit tranche moins qu'il n'encadre : information publique loyale sur les motifs, mesures limitées dans le temps et dans l'espace, attention aux effets sur les plus vulnérables, et voies de recours ouvertes. C'est dans cet encadrement — plus que dans le choix d'un camp — que se joue la qualité juridique d'une politique de santé publique.

L'essentiel
La police sanitaire prévient les risques collectifs par règlements, inspections et mesures contraignantes ; en urgence, ses pouvoirs se renforcent mais restent soumis à légalité, nécessité, proportionnalité, temporalité et contrôle du juge.

Exemple — Mesure fictive de salubrité — le « Marché Zambougou » et la proportionnalité

```
DOSSIER D'ÉCOLE — marché, commune et chiffres fictifs

CONSTAT (inspection des services compétents, fictive)
Points d'eau du marché non protégés ; dallage dégradé ;
évacuation des eaux usées insuffisante aux abords des
étals de denrées. Risque sanitaire collectif allégué.

MESURE ENVISAGÉE PAR LA COMMUNE FICTIVE
Mise en demeure de remettre en état, puis fermeture du
seul périmètre des denrées tant que les travaux ne sont
pas exécutés (mesure ciblée, pas de fermeture totale).

TRAVAUX ESTIMÉS (devis fictif)
Protection des points d'eau ..... 900 000 F
Réfection du dallage ............. 1 100 000 F
Évacuation des eaux usées ........ 500 000 F
TOTAL ........................... 2 500 000 F
(900 000 + 1 100 000 + 500 000 = 2 500 000)

TEST DE PROPORTIONNALITÉ (à dérouler)
Aptitude : les travaux visent-ils le risque constaté ?
Nécessité : une mesure moins contraignante suffit-elle ?
Équilibre : charge pour les commerçants contre bénéfice
sanitaire pour les usagers — des deux côtés, en idées.
```

À retenir

- Police sanitaire = prévention collective : elle peut contraindre avant le dommage, mais seulement sur une base légale et sous contrôle du juge.
- Le test de proportionnalité tient en trois questions : apte ? nécessaire ? supportable au regard du bénéfice attendu ?
- L'urgence renforce les pouvoirs sans suspendre les exigences : temporalité, motivation, information et recours restent dus.

Exercice

Une autorité fictive envisage, après un constat d'insalubrité limité à deux étals d'un marché fictif, la fermeture totale et indéterminée de l'ensemble du marché. Applique le test de proportionnalité en trois questions et propose la mesure juridiquement préférable, en présentant loyalement l'argument contraire.

✔ Corrigé
Aptitude : la fermeture totale est apte à faire cesser le risque, mais elle dépasse le foyer constaté, limité à deux étals. Nécessité : une mesure moins contraignante et également efficace existe — fermeture ciblée des étals concernés assortie d'une mise en demeure de travaux ; la fermeture totale échoue donc au test de nécessité. Équilibre : priver durablement tous les commerçants de leur activité et les usagers de leur marché, pour un risque localisé, impose un sacrifice disproportionné ; l'argument contraire — la crainte d'une contamination diffuse et la difficulté des contrôles partiels — est réel mais il justifie des inspections renforcées et une mesure réexaminée à bref horizon, pas une fermeture totale et indéterminée, qui cumule les deux vices : excès d'étendue et absence de terme. La mesure préférable : fermeture ciblée, travaux exigés, contrôle de réouverture. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les textes sanitaires en vigueur et un professionnel du droit.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Le règlement amiable d'un différend d'indemnisation fictif

Un patient fictif et un établissement fictif sont en différend : la personne réclame la réparation d'un préjudice qu'elle évalue à 3 200 000 F (détail fictif : 1 200 000 F de frais restés à charge, 1 100 000 F de perte de revenus, 900 000 F de préjudice moral). L'établissement conteste toute faute ; son assureur propose d'ouvrir une discussion amiable sur la base d'une expertise conjointe. Travail demandé : 1) rappelle les conditions d'une responsabilité pour faute et pourquoi la voie amiable ne les supprime pas ; 2) construis le déroulement d'une négociation raisonnée (préparation, expertise, offre chiffrée) ; 3) l'expertise conjointe évalue le préjudice global à 3 200 000 F et la part imputable à 75 pour cent à titre d'exercice : calcule l'offre de transaction cohérente et propose un échéancier bouclé.

✔ Corrigé du TD 1
1) La responsabilité pour faute exige une faute, un dommage et un lien de causalité ; la voie amiable ne dispense pas de les établir, elle change seulement le cadre de la discussion : ce qui serait plaidé devant le juge est débattu autour d'une table, dossier médical et expertise à l'appui. Sans faute établie ni préjudice justifié, la transaction reposerait sur du sable ; avec des éléments solides, elle évite la durée et le coût du procès aux deux parties. 2) Déroulé raisonné : échange des pièces (dossier médical complet, justificatifs des montants poste par poste) ; expertise conjointe contradictoire, dont le rapport éclaire sans lier ; réunion de négociation où chaque partie expose sa lecture du rapport ; offre écrite et motivée ; si accord, transaction écrite décrivant les concessions réciproques et éteignant le différend. 3) Calcul : préjudice évalué 3 200 000 F (1 200 000 + 1 100 000 + 900 000 = 3 200 000) ; part imputable d'exercice 75 pour cent, soit 3 200 000 x 75 / 100 = 2 400 000 F ; offre de transaction cohérente : 2 400 000 F, payable en trois versements égaux de 800 000 F (3 x 800 000 = 2 400 000), échéancier arrêté dans l'acte de transaction. Reste à vérifier avant signature : l'identité et la capacité des signataires, la mention expresse des concessions, et le sort des recours éteints par l'accord. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les textes sanitaires en vigueur et un professionnel du droit.

TD 2 — Audit des demandes d'informations dans un centre fictif

Le « Centre de soins fictif des Palmiers » tient un registre de ses demandes d'informations couvertes par le secret : sur une période d'exercice, 12 demandes ont été consignées — 5 émanent des patients eux-mêmes (accès à leur dossier), 4 de tiers sans accord des personnes (deux employeurs fictifs, un assureur fictif, un proche fictif), et 3 relèvent d'une équipe de soins pour une prise en charge en cours. Travail demandé : 1) vérifie l'arithmétique du registre ; 2) classe chaque catégorie de demande selon le mécanisme applicable (droit d'accès, refus motivé, secret partagé) ; 3) propose trois mesures d'organisation pour sécuriser le traitement des demandes à l'avenir.

✔ Corrigé du TD 2
1) Arithmétique : 5 + 4 + 3 = 12 demandes — le registre est cohérent. 2) Classement : les 5 demandes des patients relèvent de leur droit d'accès au dossier (leçon 3) : elles doivent aboutir, directement ou par un professionnel désigné, seuls des frais de reproduction pouvant être facturés. Les 4 demandes de tiers sans accord appellent un refus motivé et tracé (leçon 4) : ni l'employeur, ni l'assureur, ni le proche n'ont qualité à recevoir des informations couvertes ; l'assureur ne pourra être destinataire qu'avec l'accord exprès de la personne, limitée aux pièces nécessaires. Les 3 demandes internes relèvent du secret partagé : transmission entre soignants de la même prise en charge, limitée au nécessaire, personne informée, trace au dossier. 3) Mesures d'organisation : un formulaire unique de demande identifiant le demandeur et sa qualité ; une règle écrite « toute réponse se motive et se trace » affichée au secrétariat ; une revue périodique du registre par la direction du centre pour détecter les demandes répétées d'un même tiers et rappeler les règles aux équipes. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les textes sanitaires en vigueur et un professionnel du droit.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Construire la charte des droits des usagers d'un centre fictif

Par groupes, vous êtes les juristes du « Centre de soins fictif du Plateau ». Mission : rédiger une charte des droits et devoirs des usagers, affichable à l'accueil, en une page, couvrant au minimum : l'information, le consentement et le refus, l'accès au dossier, le secret, la voie de réclamation. Joignez un plan de mise en œuvre chiffré avec le budget fictif suivant, à boucler exactement : impression et affichage de la charte 150 000 F ; formation du personnel d'accueil et des secrétariats 600 000 F ; registres et formulaires (demandes, traces de consentement, réclamations) 250 000 F. Livrables : la charte rédigée en langage clair, le plan de mise en œuvre en cinq actions, et la vérification écrite du budget.

✔ Attendus du TP 1
Charte attendue (extraits de la rédaction type) : « Vous avez le droit d'être informé, en langage clair, sur votre état et sur les soins proposés, leurs bénéfices et leurs risques sérieux, ainsi que sur les alternatives. Aucun acte de soins ne peut être pratiqué sans votre accord libre ; vous pouvez refuser un soin : votre décision est entendue, expliquée et notée à votre dossier. Vous pouvez consulter votre dossier médical, directement ou par l'intermédiaire du professionnel que vous désignez ; seuls des frais de copie peuvent vous être demandés. Ce qui concerne votre santé est secret : il n'est partagé qu'entre les professionnels qui vous soignent, sauf votre accord ou une obligation prévue par la loi. Si quelque chose vous semble anormal, vous pouvez déposer une réclamation auprès de la direction du centre, qui doit vous répondre. » Plan en cinq actions : validation de la charte par la direction et les représentants des usagers ; impression et affichage aux points d'accueil ; formation du personnel ; ouverture des registres ; première revue d'application avec le registre des réclamations. Vérification du budget : 150 000 + 600 000 + 250 000 = 1 000 000 F — le budget fictif est intégralement et exactement affecté. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les textes sanitaires en vigueur et un professionnel du droit.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Consentement et personne protégée (situation fictive) : un patient fictif, placé sous un régime de protection juridique, doit recevoir un acte de soins programmé. Sa représentante légale fictive signe un formulaire, mais le patient, présent, manifeste clairement son opposition. L'équipe demande l'avis du juriste : la signature de la représentante suffit-elle à passer outre ? Construis la réponse en distinguant le rôle du représentant et la place de la volonté de la personne protégée.

✔ Corrigé
Non, la signature ne suffit pas à passer outre. Le représentant intervient pour suppléer ou assister la personne protégée selon le régime applicable, mais la personne protégée n'est pas effacée du processus : son consentement doit être recherché et son opposition prise au sérieux, d'autant plus manifeste qu'elle est clairement exprimée. La démarche correcte : suspendre l'acte programmé (hors urgence), reprendre le processus d'information avec le patient et la représentante ensemble, vérifier ce que le régime de protection prévoit pour ce type de décision, tracer l'ensemble au dossier et, si le désaccord persiste, saisir les voies prévues par les textes — juge des tutelles en fonction — plutôt que de forcer le passage. La protection juridique protège la volonté de la personne ; elle ne la remplace pas mécaniquement. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les textes sanitaires en vigueur et un professionnel du droit.

Exercice 2

Accès au dossier d'un ayant droit (situation fictive) : après le décès d'un patient fictif, sa fille fictive demande la communication de l'intégralité du dossier « pour tout savoir

». L'établissement hésite. Analyse la demande : qui peut accéder, à quoi, sous quelles conditions et quelles limites — et termine par le calcul des frais de reproduction si le dossier fictif compte 40 pages et le tarif d'exercice est de 50 F la page.

✔ Corrigé
L'accès des ayants droit n'est pas un accès général de curiosité : il est encadré par les textes et limité à des finalités reconnues — en idées, connaître les causes du décès, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir des droits — et aux seuls éléments nécessaires à la finalité invoquée. La fille doit donc préciser le motif de sa demande ; l'établissement vérifie sa qualité d'ayant droit, peut proposer un accès par l'intermédiaire d'un professionnel désigné, et écarte les éléments couverts sans lien avec la finalité, notamment ceux qui concerneraient des tiers. Le secret médical survit au décès : il protège encore la personne disparue et sa famille elle-même. Frais de reproduction, données d'exercice : 40 pages x 50 F = 2 000 F, seuls frais pouvant en principe être mis à la charge de la demanderesse. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les textes sanitaires en vigueur et un professionnel du droit.

Exercice 3

Police sanitaire d'un local fictif : un service d'inspection fictif constate, dans un local fictif de restauration rapide, des manquements d'hygiène portant sur l'eau, les surfaces et l'évacuation. Le devis fictif des travaux s'établit ainsi : plomberie et eau 700 000 F, surfaces et carrelage 650 000 F, ventilation et évacuation 450 000 F. Travail demandé : 1) boucle le devis ; 2) décris la gradation des mesures à la disposition de l'autorité (de la moins à la plus contraignante) ; 3) explique pourquoi la fermeture immédiate et définitive serait juridiquement fragile en l'état du dossier.

✔ Corrigé
1) Devis : 700 000 + 650 000 + 450 000 = 1 800 000 F — le coût total des travaux fictifs est de 1 800 000 F. 2) Gradation : rapport d'inspection motivé porté à la connaissance de l'exploitant ; mise en demeure de réaliser les travaux avec possibilité de présenter des observations ; le cas échéant, fermeture administrative temporaire et ciblée du local jusqu'à exécution et nouveau contrôle ; suites contraventionnelles en catégories si les manquements persistent. Chaque échelon se justifie par l'inefficacité du précédent, dans l'esprit du test de proportionnalité de la leçon 7. 3) Fragilité d'une fermeture immédiate et définitive : elle cumule l'absence de procédure contradictoire préalable, l'excès de durée (définitive alors qu'une remise en état est possible et chiffrée) et l'absence de lien gradué avec la gravité du risque ; une mesure temporaire, motivée et réexaminée après travaux atteindrait le même but sanitaire avec une atteinte moindre à la liberté d'entreprendre. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les textes sanitaires en vigueur et un professionnel du droit.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Le droit de la santé, par rapport au droit médical, est…

A) Un domaine plus étroit, limité au cabinet du médecin

B) Un domaine plus large : il contient le droit médical et ajoute l'organisation du système, les produits et la santé publique

C) Un synonyme exact, sans différence d'objet

2. Dans l'organisation malienne décrite par fonctions, la référence désigne…

A) La recommandation d'un patient par un proche

B) Le document de fin d'hospitalisation

C) Le mécanisme par lequel un échelon de soins oriente un patient vers l'échelon disposant du plateau technique adapté

3. Un consentement valable aux soins suppose…

A) Une information préalable claire et adaptée, et une volonté libre — c'est un processus, pas une signature

B) Uniquement un formulaire signé, même sans entretien

C) L'accord de la famille en toutes circonstances

4. Le dossier médical sert d'abord à…

A) Facturer les soins

B) La continuité des soins et la mémoire juridique de la prise en charge : le patient y accède, l'établissement le conserve

C) Alimenter les statistiques commerciales de l'établissement

5. Le secret médical couvre…

A) Uniquement les diagnostics écrits au dossier

B) Uniquement ce que le patient demande de taire

C) Tout ce que le professionnel a appris, vu, entendu ou compris dans l'exercice, y compris la présence d'une personne dans un service

6. Le « secret partagé » signifie que…

A) Le secret peut être raconté à toute l'équipe élargie, y compris administrative

B) Les professionnels participant à la même prise en charge peuvent s'échanger les informations strictement nécessaires à la continuité des soins

C) Le dossier devient accessible aux autres patients du service

7. Un dommage survient au cours de soins conformes, sans aucun manquement établi. En principe…

A) La responsabilité pour faute est automatiquement engagée

B) Le soignant est pénalement coupable

C) Il s'agit d'un aléa : sans faute, le triptyque de la responsabilité pour faute est incomplet

8. Devant le juge, le rôle de l'expert médical est de…

A) Trancher la question de droit à la place du juge

B) Éclairer le juge sur les points techniques, dans une procédure contradictoire ; le juge reste seul décideur

C) Défendre systématiquement le professionnel mis en cause

9. L'autorisation de mise sur le marché d'un produit de santé est…

A) Un simple enregistrement sans examen

B) Une formalité commerciale délivrée par le grossiste

C) Un mécanisme d'évaluation préalable de la qualité, de la sécurité et de l'intérêt du produit par une autorité compétente

10. Une mesure de police sanitaire est proportionnée si elle est…

A) La plus sévère possible, pour dissuader

B) Apte à atteindre le but sanitaire, nécessaire faute de mesure moins contraignante, et supportable au regard du bénéfice attendu

C) Adoptée sans motivation pour aller plus vite

Corrigés du QCM

1. Réponse B — Le droit médical gouverne la relation de soins ; le droit de la santé englobe en outre le système de soins, son financement, les produits de santé et la police sanitaire.

2. Réponse C — La pyramide des soins fonctionne par référence et retour d'information : chaque échelon traite ce qu'il peut et oriente le reste.

3. Réponse A — Libre et éclairé : le consentement se construit dans le dialogue et reste révocable ; la signature seule ne prouve pas l'information.

4. Réponse B — Le dossier a une double fonction : outil de soins (continuité, sécurité) et pièce juridique (preuves de l'information, du consentement et des actes).

5. Réponse C — Le champ du secret est large : il naît de l'exercice professionnel, pas de la seule confidence du patient.

6. Réponse B — Le partage est limité aux soignants de la même prise en charge, aux informations nécessaires, avec information de la personne et traçabilité.

7. Réponse C — Faute, dommage, causalité : le dommage seul ne suffit pas ; l'aléa sans faute ne se confond pas avec une faute.

8. Réponse B — L'expertise est un avis technique discuté par les parties ; la décision de responsabilité appartient au juge.

9. Réponse C — Autoriser avant, surveiller pendant (pharmacovigilance), retirer et réparer après : telle est la logique de l'encadrement des produits.

10. Réponse B — Aptitude, nécessité, équilibre : les trois questions du test de proportionnalité, sous base légale et contrôle du juge.

Résumé — les notions importantes

• Droit de la santé : un domaine transversal qui contient le droit médical et organise le système de soins, les professions, les produits et la santé publique, à partir de

sources plurielles (textes, déontologies, jurisprudence, droit international sanitaire).

• Organisation malienne par fonctions : pilotage ministériel, pyramide de soins (centre de santé communautaire, centre de référence, hôpital régional, hôpitaux nationaux) reliée par la référence, financement mixte et couverture par mutualisation du risque.

• Droits des patients : information claire et adaptée, consentement libre et éclairé conçu comme un processus (avec le refus pour revers), et accès au dossier médical, mémoire de la relation de soins.

• Secret médical : il couvre tout ce qui est appris dans l'exercice ; il appartient au patient, se partage strictement au sein de l'équipe de soins et ne cède que devant des exceptions légales identifiables — toute décision se motive et se trace.

• Responsabilité médicale : distinguer la faute de l'aléa ; triptyque faute-dommage-causalité ; obligation de moyens du soignant ; trois ordres indépendants (civile, administrative, pénale) plus la voie disciplinaire ; expertise qui éclaire, juge qui décide.

• Produits de santé et pharmacie : autorisation préalable d'évaluation, circuit organisé sous monopole de dispensation, pharmacovigilance et mesures graduées jusqu'au retrait ; le marché informel fait perdre toutes les garanties.

• Police sanitaire : prévention collective par règlements et inspections ; en urgence, des pouvoirs renforcés mais jamais sans base légale, nécessité, proportionnalité, temporalité et contrôle du juge.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 2 — Le système de santé en Afrique : défis, réalités et solutions PARTIE 1

Chaîne : GLOBAL SANTÉ ACTU · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

Une présentation de l'organisation des systèmes de santé africains : niveaux de soins, rôle des centres de santé et des hôpitaux, défis de financement. Elle donne des images concrètes à la description par fonctions de la leçon 2, à transposer au cadre malien étudié dans le cours.

https://www.youtube.com/watch?v=P6hpPfIh6Wg

Leçon 3 — Consentement aux soins - LA LOI ET VOUS (par Éducaloi)

Chaîne : Éducaloi · Langue : Français · Niveau : Débutant

Un organisme d'information juridique explique les règles générales du consentement aux soins et le droit de les refuser. Le cadre présenté est québécois, mais le mécanisme — information, volonté libre, refus possible — est exactement celui de la leçon 3.

https://www.youtube.com/watch?v=eM9WSbPg95M

Leçon 3 — Information du patient et consentement à l'acte

Chaîne : Institut Montsouris · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire
Un établissement de santé présente sa démarche d'information du patient avant les soins : comprendre sa situation, les options proposées et leurs risques pour décider en connaissance de cause. Un complément concret au processus de consentement éclairé de la leçon 3.

https://www.youtube.com/watch?v=uInBvuBbdaM

Leçon 4 — Qu'est-ce que le secret médical et qui peut le rompre ?

Chaîne : Europe 1 · Langue : Français · Niveau : Débutant
Un médecin explique, dans une chronique radio filmée, ce que recouvre le secret médical et les rares hypothèses où il peut être levé. À écouter avec la grille de la leçon 4 : qualité du demandeur, base légale, nécessité, trace.

https://www.youtube.com/watch?v=jP-JzTJ3Co8

Leçon 5 — La Responsabilité de l'Infirmier (IDE) : Civile, Administrative et Pénale | Cours Complet UE 1.3

Chaîne : santé plus · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire
Un cours complet sur les trois régimes de responsabilité des professionnels de santé : civile, administrative (faute de service et faute personnelle) et pénale. C'est le prolongement direct de la leçon 5, avec un tableau comparatif final utile en révision.

https://www.youtube.com/watch?v=MyukSLAwYY0

Sources et références

• Législation sanitaire malienne (lois et règlements relatifs à la santé publique, à l'organisation des soins, aux professions et aux établissements de santé) : à consulter dans leur version en vigueur auprès des sources officielles.

• Code de déontologie médicale et codes de déontologie des autres professions de santé : textes déontologiques de référence, nommés en général dans ce cours.

• Organisation mondiale de la Santé (OMS) — principes de santé publique, organisation des systèmes de santé et coopération sanitaire internationale : documentation publiée sur who.int.

• Cours DRO-L2-14 (secret professionnel), DRO-L1-24 (état d'urgence et libertés) et DRO-L2-13 de cette bibliothèque, pour les fondements mobilisés par les leçons 4 et 7.

• Manuels universitaires de droit de la santé et de droit médical en accès libre dans les bibliothèques universitaires francophones — demande les références à jour à la bibliothèque de l'IAM.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !